פרק 11

הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה

הפיצוי בגין הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה[1] משתלם הן כנזק מיוחד לעבר והן כנזק עתידי. להלן נסקור סקירה קצרה את השתלשלות הפיצוי בראש נזק זה.

11.1 המצב בעבר

בעבר, כאשר הביטוח הרפואי בקופות החולים היה וולונטרי, מי שלא היה לו ביטוח נדרש לשלם על הטיפול שקיבל. מקרה שבו לאדם לא היה כלל ביטוח בריאות בקופת חולים, היה מקרה נדיר.

אם אדם נפגע בתאונה, אף על פי שהיה לו ביטוח בריאות, הוא לא היה זכאי לקבל טיפול מהקופה. במקרה זה, המזיק היה מחוייב לפצותו באופן מלא בהתאם להוצאותיו הרפואיות לעבר ולעתיד.

בפועל, במקרה הרגיל שבו אדם עם ביטוח בריאות נפגע, מקובל היה שהנפגע המציא התחייבות לקופת חולים שיחזיר לה את עלות הטיפולים בו, בהתאם לכך קיבל את הטיפול הרפואי ואת עלות הטיפולים אותה גבה מהמזיק באופן מלא בהליך הנזיקי, העביר בהמשך לקופת חולים.

---

1 במשפט העברי נקרא פריט נזק זה: 'ריפוי' (משנה, בבא קמא, ח א).

כך, התובע היה מקבל כפי ניזקו בלבד; המזיק לא יכול היה לנכות את דמי הטיפול שקיבל התובע הניזוק מקופת חולים, אלא היה עליו לפצות את התובע, ולקופת חולים לא הייתה כל זכות לתביעת השבה מול המזיק.[2]

11.2 המצב בעקבות חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

אולם מצב זה השתנה עם חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.[3] עתה ההצטרפות לקופת חולים היא חובה. התשלומים החודשיים משולמים למדינה בדרך של מס בריאות בהתאם להכנסה.

חוק הבריאות קבע כי זכותו של כל תושב בישראל לקבל את שירותי הבריאות לפי החוק,[4] וכי האחראית לספק לו את מלוא שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי, היא קופת החולים שבה הוא חבר.[5] חוק הבריאות אף הגדיל וקבע כי סירוב מצידה של קופת חולים לספק את שירותי הבריאות לפי חוק הבריאות הוא משום עבירה פלילית.[6] חוק הבריאות מפרט את סל שירותי הבריאות אשר יינתנו למבוטחים,[7] וקובע כי:[8]

---

2 ראו ע"א 4431/17 **פלוני נ' פלוני** ס' 31 (נבו 3.10.2019), כן ראו ע"א 5557/95 **סהר חברה לביטוח בע"מ נ' אלחדד**, פ"ד נא(2) 724, 737 (1997). בפסיקה ניתנו הסברים שונים להיעדרה של זכות המזיק לנכות את סך הטיפול שקיבל התובע מהפיצוי. ההסבר המקובל היה כי מכיוון שהתובע היה מחוייב להשיב את הוצאות טיפולו לקופת חולים הוא היה זכאי לקבל מהמזיק גם את הפיצוי בגין הוצאות רפואיות אלה. על כן, לקופת חולים כמיטיב לא עמדה זכות תביעה כנגד המזיק, ולכן המזיק לא היה צפוי להיתבע על־ידי המיטיב־הקופה (ס' 13 לפסק הדין).

3 חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, ס"ח 156 (להלן: חוק הבריאות).

4 ס' 3(א) לחוק הבריאות.

5 ס' 3(א) לחוק הבריאות.

6 ס' 3(ג) ו־21(א) לחוק הבריאות.

7 ס' 6 ו־7 ובתוספות לחוק הבריאות.

8 ס' 3(ד) לחוק הבריאות.

"שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף 13".

סעיף חשוב לענייננו הוא זכות החזרה של קופת החולים בגין הסכומים שהשתלמו על ידה לתובע, מאת המזיק ומבטחתו ("הטבת נזק"):[9]

"קופת חולים או נותן שירותים, שנתנו שירותי בריאות למי שחלה או למי שנפגע ממזיק זכאים להיפרע את הטבת הנזק מהמזיק או ממבטחו או מכל אדם אחר, בשל חבותם לפי כל דין או לפי כל חוזה ביטוח, בסכום ההוצאות אשר הוציאו בפועל למתן שירותי הבריאות למי שנפגע או שחלה כאמור. [...]".

בהלכת **אלחדד**,[10] נקבע כי הזכות לקבלת שירותי בריאות קבועה לא רק במקרה 'רגיל' שבו אדם חולה ונזקק לקבלת השירות הרפואי, אלא גם במקרה שבו יש מזיק הגורם לנזק כבמקרה של 'תאונה' (הן בתביעה נזיקית המתנהלת לפי פקנ"ז והן זו המתנהלת לפי פלת"ד).

הזכות לקבלת שירותים רפואיים לניזוק היא מקופת החולים. קופת החולים תשתחרר מזכות זו, רק במקרה שיש חובה על פי חיקוק אחר לגוף אחר לתת את שירותי הבריאות.[11] לדוגמה, מקרה שבו הניזוק נפגע בתאונה המוגדרת כתאונת עבודה – במקרה כזה הביטוח הלאומי הוא זה שמעניק לנפגע גמלאות בעין, וכן הוא

---

9 ס' 22 לחוק הבריאות.

10 הלכת **אלחדד**, לעיל ה"ש 2.

11 ס' 3(א) לחוק הבריאות.

זכאי "לריפוי, להחלמה, לשיקום רפואי ולשיקום מקצועי". 'ריפוי' כולל אשפוז רפואי, מכשירים אורתופדיים ותרפויטיים, הספקתם, תיקונם והחלפתם.[12]

נשאלת השאלה האם המזיק רשאי לקזז מסך הנזק שעליו לשלם לתובע את עלות הטיפולים שהתובע זכאי לקבל מקופת חולים במסגרת חוק הבריאות? בעניין **אלחדד** נפסק כי שהתשובה לכך **חיובית**. נקבע כי אם קיימת זכות למיטיב נזק (קופת חולים) לחזור בתביעת השבה למזיק בגובה ההטבה שהוא העניק לניזוק, הרי שכדי שהמזיק לא יחויב ביתר, והניזוק לא יקבל ביתר, יש **לקזז** מתביעת הניזוק את המזיק, את שווי ההטבה שמעניקה קופת חולים לניזוק.[13] כדברי כב' השופט ת' אור:

> "אכן, דעתי היא, כי על יסוד הנמקות דומות לאלה שאומצו ביחס לניכוי גימלאות המוסד, יש לנכות גם את הוצאות הטיפולים הרפואיים אשר הניזוק זכאי לקבל מקופת החולים שבה הוא חבר. הענקת הזכות בסעיף 22 לחוק הבריאות לקופת חולים לתבוע מהמזיק את סכום ההוצאות שהוציאה בעבור טיפולים רפואיים שסיפקה לניזוק, מעבירה את זכויותיו של הניזוק כלפי המזיק אל קופת החולים. גם כאן חל עקרון הסוברוגציה. גם כאן יש למנוע את המצב שעל־פיו יחויב המזיק לשלם לניזוק בגין הוצאות רפואיות, ואחר־כך יהיה חשוף לתביעה מצד קופת חולים. שאם לא כן, יחויב המזיק לשלם כפל הוצאות רפואיות, ובסופו של דבר, יישא בתשלום פיצויים בשיעור העולה על סך כל הנזק של הניזוק. הדבר ימנע גם את המצב שבו יקבל הניזוק גם טיפול רפואי חינם וגם את הוצאות עלותו ועל־ידי כך יקבל פיצויים בסכום העולה על הנזק שנגרם לו".[14]

---

12 ס' 86 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, ס"ח 210 (להלן: חוק הביטוח הלאומי) כמו כן מסדיר חוק הביטוח הלאומי את דרך הספקתם של שירותים אלה, אם בחוק עצמו ואם בתקנות שהותקנו על־פיו (הלכת **אלחדד**, לעיל ה"ש 2, ס' 17).

13 הלכת **אלחדד**, לעיל ה"ש 2, ס' 25 ו־26. הסדר זה דומה להסדר הקיים במשולש מזיק–ניזוק–מל"ל.

14 שם, עמ' 752.

11.3 חריגים לכלל שהוצאות רפואיות מקוזזות מסך הפיצוי

אולם, ברור כי אם התובע לא זכאי לקבל טיפול מסויים מקופת החולים, או לקבל את הטיפול בתמורה לתשלום מיוחד לקופת החולים, הוא יוכל לתבוע את אותו טיפול מהמזיק. כך גם במקרה שבו רמת הטיפול בקופת חולים אינה מספקת, והתובע פונה לטיפול פרטי. ככל שהתובע יוכיח כי פנייתו לטיפול פרטי עומדת במבחן הקטנת ניזקו, הוא יהיה זכאי לתבוע טיפול זה מהמזיק.[15]

11.3.1 זכות קופת חולים לחזור למזיק בנזקים עתידיים

סעיף 22 לחוק הבריאות קובע כי: "קופת חולים או נותן שירותים, **שנתנו** שירותי בריאות למי שחלה או למי שנפגע ממזיק זכאים להיפרע את הטבת הנזק מהמזיק [...]" (ההדגשה שלנו – המחברים)., מכאן שזכות החזרה היא רק לנזקי עבר שהוצאו בפועל (בניגוד לזכות המל"ל שהיא גם לנזקי עבר וגם לנזקי עתיד).[16]

עם זאת, מכיוון שאין חשש כי בעתיד קופת חולים לא תממן לתובע את טיפוליו, יוכל המזיק לטעון כי אין מקום שהוא יפצה בגין טיפולים עתידיים, מכיוון שהוא חשוף לתביעה עתידית מצד קופת חולים. אך, אם קופת החולים מצטרפת לדיון כתובעת נוספת, אפשר להעריך את הטיפולים העתידיים שהיא אמורה לתת לתובע, ולא לפסוק אותם כחלק מהפיצוי לתובע אלא לפסוק אותם בתביעת ההשבה של קופת החולים.

אם הנתבע יתנגד לשלם בעבור טיפול עתידי (כאמור לקופת חולים זכות תביעה רק על טיפולי עבר ואילו טיפולי העתיד טרם הוצאו), ישנה אפשרות כי בית המשפט יקבע את זכותה של קופת חולים לקבל את סך הנזקים העתידיים, וכאשר הוצאה זו תוצא, קופת חולים תוכל לשוב ולתבוע את המזיק.[17]

---

15 שם, עמ' 753.

16 ס' 328 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995.

17 הלכת **אלחדד**, לעיל ה"ש 2, ס' 31.

11.3.2 פסיקה בעקבות עניין אלחדד

המצב שנוצר בעקבות הלכת **אלחדד**,[18] הוא כי אין לפסוק בתביעה הנזיקית לתובע פיצוי בגין הטיפולים הרפואיים כי אלו מכוסים על ידי קופת חולים מכוח חוק הבריאות, למעט הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על ידי חוק הבריאות כאמור לעיל, אותן יוכל הניזוק לתבוע מהמזיק, וזה בתורו, לא יהיה חשוף לתשלום סכומים אלו לקופת החולים. בפסיקה שנפסקה סמוך לאחר הלכת **אלחדד** העקרונות שהותוו בה לא היו מבוררים דיים. כך, לדוגמה, בעניין **בר זאב**,[19] שניתן סמוך לאחר פסק הדין בעניין **אלחדד**.

במקרה זה פסק בית המשפט המחוזי לילדה בת 13 כ־800,000 ש"ח כהוצאות רפואיות עתידיות לטיפולים פסיכיאטריים ופסיכולוגיים. בית המשפט סבר כי חוק הבריאות לא שינה מן המצב המשפטי ששרר לפני כניסתו לתוקף, ולכן פסק סכום פיצוי עתידי בגין הטיפול כנגד המזיק. בינתיים ניתן פסק הדין בעניין **אלחדד** שלפיו תובע לא יהיה זכאי לקבל מהמזיק פיצוי עבור טיפולים שהוא יכול לקבלם בחינם מקופת חולים. אם כן, צפוי היה שבית המשפט העליון יבטל את חיוב המזיק לשלם פיצוי עתידי בגין הוצאות רפואיות. אלא שלא כך היה הדבר.

בערעור,[20] בית המשפט העליון החליט להותיר בידי התובעת סך של 200,000 ש"ח. הטעם לכך היה כי בשל תקופת המעבר בין המצב שטרם כניסת חוק הבריאות לתוקף ולאחריו נוצר מצב לא ברור. התובעת קיבלה טיפולים בתחום הנפשי לאחר מתן פסק הדין המחוזי ושילמה עבורם, ולא היה ברור אם היא תקבל סכומים אלו בחזרה מקופת החולים אליה היא השתייכה, בשל חוסר הבהירות. מטעם זה סבר בית המשפט העליון כי:

---

18 שם.

19 ת"א 2553/88 **בר זאב נ' מוחמד**, (נבו 25.6.1996).

20 ע"א 6431/96 **בר זאב נ' מוחמד**, פ"ד נב(3) 557 (1998).

"יש להביא בחשבון תקופה של הסתגלות הקשורה במעבר מהטיפול הפסיכולוגי והפסיכיאטרי שקיבלה התובעת בעבר לטיפול שתקבל מרופאי קופת החולים שאליה היא משתייכת".[21]

כמו כן חשש בית המשפט כי בעתיד חלק מהטיפולים לא ימומנו על ידי קופת החולים, מה שיצריך את התובעת להוציא הוצאות כספיות שלא יוחזרו לה על ידי הקופה. מסיבות אלו ועל אף חוק הבריאות פסק בית המשפט פיצוי עתידי בגין הוצאות רפואיות.

בעקבות הפסיקה בעניין **בר זאב** נשאלה השאלה אם קביעה זו משנה את האמור בהלכת **אלחדד**? והאם משמעות הדבר שאפשר לפסוק בגין טיפולים רפואיים לעתיד גם לאחר חקיקת חוק הבריאות והלכת **אלחדד**?

לכאורה נראה היה שלא. אפשר היה לומר כי בית המשפט פסק את שפסק שכן מדובר היה בתקופה הסמוכה לשינוי החקיקתי, והוא התרשם כי הכללים המחייבים טרם נוסחו באופן מחייב, ומהחשש שהתובעת תוציא הוצאות לטיפולים שלא יוחזרו, הוא מצא לפסוק פיצוי בגין הוצאות רפואיות עתידיות. אולם, החשש מפני מצב שבו תובע לא יקבל בעתיד מקופת חולים את הטיפולים המגיעים לו, המשיך להופיע בפסיקה.

כך גם בעניין **קרנית נ' גינת**,[22] שניתן סמוך להלכת **אלחדד**, נקבע פיצוי לתובעת בגין הצורך בהוצאות לטיפולים עתידיים, מחשש שבעתיד התובעת עלולה שלא לקבל טיפולים מקופת חולים מטעמים שונים כמו תקלה או טעות.

יצוין כי גם בעניין **גינת** כמו בעניין **בר זאב**, בית המשפט העליון מצא להפחית מהסכום שפסק בית המשפט המחוזי, והעמיד את הפיצוי על סך של 75,000 ש"ח במקום 300,000 ש"ח.[23]

---

21 שם, בעמ' 559.

22 ע"א 8109/95 **קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' גינת**, פ"ד נב(5) 637 (1998).

23 טעם דומה ניתן גם בע"א 2801/96 **אל־על נתיבי אוויר לישראל נ' יפרח**, פ"ד נה(1) 817 (1998) שם קבע בית המשפט העליון פיצוי מסוים בגין הוצאות לטיפולים פיזיותרפיים, למקרים שבהם בגלל טעות או תקלה, לא יקבל התובע את הטיפול שהוא זקוק לו מטעם

גם בפסק דין מאוחר יותר בעניין **קורנר**,[24] שניתן כבר בשנת 2001, מצא בית המשפט לחייב את המזיק לפצות את התובעת בהוצאות רפואיות אשר "יתכן ולא יהיו מכוסים על ידי סל הבריאות". במקרה זה סבר בית המשפט כי:

> "לגבי חלק מהתרופות היא עלולה להידרש לשלם סכומי כסף. בהתחשב במצבה, היא נזקקת לשקיות שתן ועליה לשאת ב־10% מעלותן. בנסיבות אלה, היה מקום לחייב את המערערות בתשלום בגין אותן הוצאות רפואיות או פרה־רפואיות אשר לא מכוסות על ידי חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחקיקת המשנה על פיו".

גם כאן מצא בית המשפט להפחית את הסכום מ־600,000 ש"ח ל־300,000 ש"ח. תשומת הלב כי במקרה זה, הפיצוי לא ניתן בשל חשש מתקלה או טעות כמו במקרים שנסקרו לעיל, אלא מחשש שחלק מההוצאות העתידיות לא יכוסו על ידי ביטוח הבריאות. בית המשפט הסתפק **בחשש** בלבד לאי־מתן הטיפול בעתיד, כדי לחייב את המזיק לפצות את התובע בגין כך.

בעניין **צוברי**,[25] בית המשפט פסק סכום נמוך של 15,000 ש"ח בגין הצורך לבצע ניתוח לשיפור הצלקות (שם דובר על נכות בשיעור 10% בגין כוויות שניתנה על ידי מומחה בית המשפט). בית המשפט קבע כי אם תהיה הצדקה רפואית לביצוע ניתוחים לשיפור הצלקות, כי אז, לפי ההלכה הפסוקה וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ניתוחים אלה אמורים להיות מכוסים, ב"סל הבריאות" של חוק הבריאות ואולם:

> "למקרה ומסיבה כלשהי תזדקק התובעת לטיפול רפואי כזה עקב התאונה הנדונה, שלא יהא מכוסה במסגרת 'סל הבריאות', וכדי שלא תימצא התובעת במצב של חסרון כיס, ראוי הוא לפסוק לה, לפי

קופת חולים. גם במקרה זה הסכום שאושר בעליון היה נמוך משמעותית מן הסכום שנפסק על ידי בית המשפט המחוזי.

24 ע"א 81/00 **קורנר נ' אוחיון** (נבו 5.4.2001).

25 ת"א (מחוזי חי') 335/91 **צוברי (קטינה) נ' נעמ"ת** (נבו 12.4.1999).

> הערכתי, פיצוי כולל שיקח בחשבון את האפשרות שמסיבה כלשהי לא תכוסה הוצאה זו, כולה או חלקה, ע"י קופת חולים".

אם נסכם את שעלה מהפסיקה שנסקרה, נאמר כך: בעקבות חוק הבריאות והלכת **אלחדד**, המצב הנוהג כיום כי קופות חולים מחוייבות להעניק טיפולים רפואיים לנפגעי תאונות, ולפיכך אין מקום כי המזיק יפצה את המזיק בגין טיפוליו הרפואיים.

מכיוון שהמזיק חשוף לתביעת השבה מצד קופת חולים עבור הטיפולים שהם העניקו למזיק, יש להיזהר שלא לחייב את המזיק בפיצוי עבור טיפולים שניתנו על ידי קופת חולים לניזוק, שכן אז המזיק ישלם פעמיים על אותו טיפול: לניזוק ולקופת חולים, ומאידך גיסא הניזוק יקבל פעמיים עבור אותו טיפול: מהמזיק ומקופת החולים. מצב זה הוא בניגוד לעקרונות־העל של דיני נזיקין, שניזוק יקבל כפי ניזקו ולא יותר ומזיק ישלם כפי הנזק שגרם ולא יותר.

למרות חוק הבריאות והלכת **אלחדד**, עדיין ייתכנו מצבים שהמזיק יחויב בפיצוי עבור טיפולים רפואיים. לדוגמה, אם יוכיח התובע כי אינו זכאי לקבל טיפול מסויים מקופת חולים. בפסיקה אף נתקלנו שדי בחשש כזה לאי־קבלה עתידית של הטיפול כדי להורות למזיק לפצות בכך את הניזוק,[26] ואולם ראוי שחשש זה יהיה ממשי ולא חשש רחוק או חשש בעלמא, ולצורך כך יש להביא ראיות בהתאם. או אם יוכיח התובע כי קבלת הטיפול מקופת חולים כרוכה בתמורה כספית שעליו לשלם או שהוא כבר שילם, הרי שהוא יוכל לתבוע זאת מהמזיק.

כך גם במקרה שבו התובע יוכיח (בדרך כלל על ידי מומחה רפואי שיאשר זאת) כי רמת הטיפול בקופת חולים אינה מספקת, והתובע פונה לטיפול פרטי. ככל שהתובע יוכיח כי פנייתו לטיפול פרטי עומדת במבחן הקטנת ניזקו, הוא יהיה זכאי לתבוע טיפול זה מהמזיק.[27]

עוד מצאנו בפסיקה כי בית משפט יכול לפסוק פיצוי עבור טיפול עתידי, אם הוא ישתכנע שיש סיכוי כי מתוך טעות קופת חולים לא תממן בעתיד טיפולים אלו.[28]

---

26 ראו עניין **קורנר**, לעיל ה"ש 24, ועניין **צוברי**, שם.

27 הלכת **אלחדד**, לעיל ה"ש 2.

28 עניין **בר זאב**, לעיל ה"ש 19 ועניין **גינת**, לעיל ה"ש 22.

אולם יש לשים לב כי הפסיקה שמצאה לפסוק פיצוי כאמור קבעה כי עסקינן בפיצוי מדוד ונמוך, ובית המשפט העליון, באופן שיטתי, הפחית פיצויים בגין ראש נזק זה, והעמידם על סך נמוך יחסית בהתאם למקרים הנדונים על ידו. נעיין בסיכום ההלכה בעניין זה:

"ברי כי חוק ההתייעלות לא נתכוון לפגוע בנפגע ולא להפחית מזכאותו. טיפולים להם זכאי הנפגע על פי סל הבריאות הוא אמור לקבל מקופת חולים, וכל הוצאה אחרת שאינה כלולה בסל הבריאות, חלה על חברת הביטוח. חשוב אפוא להדגיש, כקו מנחה לבית המשפט הדן בתביעה על פי חוק הפיצויים, כי יש למנוע מצב בו הנפגע 'יפול בין הכסאות' במחלוקת בין קופת חולים לבין חברת ביטוח. מצב מעין זה יכול להתרחש כאשר בית המשפט קובע בפסק דינו כי הנפגע זכאי לקבל טיפול או שירות רפואי מסוים מקופת חולים ולכן אינו זכאי לפיצוי בגינו. אולם, כאשר יבוא הנפגע לממש את זכותו הוא ייענה בסירוב על ידי קופת חולים מן הטעם שהשירות הרפואי אינו כלול בסל הבריאות, וגם תביעתו בבית הדין לעבודה תידחה. על מנת למנוע תסריט מעין זה, על בית המשפט להנחות עצמו כי בכל מקרה בו מתעורר ספק של ממש לגבי היקף הטיפולים או השירותים הרפואיים אותם זכאי הניזוק לקבל מקופת חולים על פי סל הבריאות, ברירת המחדל צריכה להיות חיובה של חברת הביטוח, בדומה למה שנפסק בעניין הראל בסוגיה של תשלום תכוף. להלכה, לא אמורה להתעורר סוגיה של כפל תשלום, כפי שנטען על ידי המבקשות, שהרי קופות החולים אמורות לשאת בשירותים הרפואיים הכלולים בסל הבריאות וחברות הביטוח ביתר השירותים הרפואיים הנובעים מהתאונה. ככל שחברת הביטוח סבורה כי טעה בית המשפט בקביעתו וכי השירות הרפואי כלול בסל הבריאות, תיכבד ותיכנס בנעלי הנפגע כמיטיבה או כחליפה, ותחזור על קופת חולים בתביעה בבית הדין לעבודה [...] בסופו של דבר, השאלה היא במישור הראייתי. בהלכת אלחדד נקבע כי 'הנטל להוכיח שאת הטיפולים והאביזרים הרפואיים הדרושים לו יוכל הניזוק (התובע) לקבל מקופת החולים, מוטל על המזיק (הנתבע)' (שם, עמ' 752). על חברת הביטוח להראות אילו שירותים רפואיים נופלים 'במגרש' של קופת חולים על פי סל הבריאות. מנגד, על התובע,

במסגרת חובתו להקטנת הנזק ולמיצוי זכויותיו, להראות כי פנה לקופת חולים ונענה בשלילה, או להניח דעתו של בית המשפט ברף הוכחה 'מתון', כי קופת החולים מסרבת ליתן לו את השירות הרפואי. משעשה כן, נותר הנטל על חברת הביטוח להראות כי על קופת החולים ליתן את השירות הרפואי".[29]

11.4 פיצוי עבור צריכת קנביס וטיפולים אחרים

במקרים המתאימים ניתן לפסוק עבור צריכת קנביס. באחד המקרים,[30] אושר לתובע, לו נכות משוקללת של 30.2% מתוכה 10% בגין תסמונת כאב עם אופי נוירופתי, רכישת קנביס. עם השנים המינון עלה מ־20 גרם ל־40 גרם. המומחית הרפואית מטעם בית המשפט אישרה כי השימוש הרפואי בליריקה ובקנביס הוא טיפול המתאים לתובע, ואולם לא הונחה תשתית ראייתית למשך התקופה שהתובע יזקק לקנביס, לכמות שייזקק, ולצורך הרפואי לכך בעתיד.

בית המשפט פסק בגין פריט הוצאות רפואיות ונסיעות לעבר ולעתיד ולצורך ברכישת קנביס סך של 120,000 ש"ח. בית המשפט חישב זאת על פי חישוב של 850 ש"ח לחודש עבור רכישת קנביס למשך עשר שנים, ועוד 30,000 ש"ח באופן גלובאלי. בית המשפט ציין כי סכום זה מתקבל גם אם מחשבים הוצאות בסך של 300 עד 350 ש"ח כממוצע חודשי ממועד התאונה ועד תום תוחלת החיים.

במקרה נוסף,[31] נקבע כי בשל העובדה שלא היה חולק שבמשך השנים התובע נזקק לכמויות גדולות של קנאביס, "ומתוך מחשבה שבעתיד התובע יידרש לטיפולים החורגים מהכיסוי של קופות החולים", נפסק פיצוי בראש הנזק של הוצאות רפואיות ונסיעות פיצוי גלובאלי, לעבר ולעתיד, בשיעור של 100,000 ש"ח.

---

29 רע"א 7325/12 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' מכבי שירותי בריאות (נבו 12.11.2013).

30 ת"א (מחוזי מר') 4693-06-18 פלוני נ' זיסרמן (נבו 5.1.2022).

31 ת"א (מחוזי י-ם) 3498/09 פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב ("הפול") (נבו 29.1.2021).

במקרה אחר,[32] לתובעת אושר שימוש בקנביס רפואי, ועל פי האמור בתצהיר, ההוצאה החודשית עומדת על סך של כ־500 ש"ח. אולם, המומחה בתחום הראומטולוגיה הבהיר שלפי הידע הרפואי הקיים הוא לא ממליץ על קנביס רפואי לחולים בפיברומיאלגיה. בנסיבות אלה ובהיעדר תשתית רפואית מספקת, לא מצא בית המשפט לחייב את הנתבעת לפצות את התובעת בגין עלות השימוש בקנביס, ואולם הוא מצא להתחשב בהמלצת המומחה בעניין טיפולי CBT ולפסוק פיצוי לעבר ולעתיד בסך 25,000 ש"ח.

בעניין **פלוני**,[33] התובע עתר לפיצוי בסך של 100,000 ש"ח עבור פריט ההוצאות הרפואיות. בית המשפט קבע כי לא הוצגו ראיות להוצאות אלו, וממילא ההוצאות מכוסות בסל הבריאות והתובע היה זכאי להחזרים מהביטוח הלאומי שכן מדובר היה בתאונת עבודה. אף על פי כן, בית המשפט מצא לפסוק באופן גלובאלי סכום של 90,000 ש"ח לעבר ולעתיד, מכיוון שהשתכנע שישנן הוצאות "שאינן מוכרות ואינן בסל, כמו טיפולים אלטרנטיביים, משككי כאבים וכו', ויתכן כי בעתיד התובע יבקש לפנות בכל זאת לטיפול נפשי".

בעניין **טוויג**,[34] טען התובע כי לאחר התאונה ובעקבות מצבו, הוא נזקק לטיפולי רפואה משלימה והומלץ לו טיפול נפשי בעלות של 320 ש"ח לשעה וכן על טיפול זוגי בעלות של 400 ש"ח. אך, בהיעדר מימון מצד הנתבעת הוא לא קיבל את הטיפולים הללו. גם במועד הסמוך למתן פסק הדין, המשיך התובע בטיפולי הידרותרפיה פעמיים בשבוע ביחידה לשיקום של בית החולים והומלץ לו על טיפולי רפואה משלימה לשם הקלה על כאבים. הנתבעת טענה כי מאחר שהתאונה היא תאונת עבודה, זכאי התובע להחזר הוצאות הטיפול הרפואי, לרבות הוצאות בגין רכישת תרופות או הוצאות נסיעה לשם קבלת טיפול רפואי מהמל"ל ועל כן, אין התובע זכאי לכל פיצוי בגין ראש נזק זה. הנתבעת גם כפרה בצורך של התובע להיזקק לטיפול רפואי, פסיכולוגי או אחר, בעתיד. בית המשפט קבע כי אף על פי

---

32 ת"א (מחוזי מר') 63008-01-17 **פלונית נ' איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ** (נבו 27.11.2021).

33 ת"א (מחוזי מר') 25081-04-19 **פלוני נ' כשרה היישוב חברה לביטוח** (נבו 27.12.2021).

34 ת"א (מחוזי ת"א) 8538-11-09 **טוויג נ' הפניקס הישראלי, חברה לביטוח** (נבו 9.11.2012).

שהטיפולים המבוקשים אמורים להיות מכוסים במסגרת חוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה–1995, בהיות התאונה בגדר תאונת עבודה, וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 בית המשפט הביא בחשבון "את האפשרות שסל שירותי הבריאות עשוי להשתנות, בפריט זה או אחר, ואת המחיר הנדרש לעתים מן החולה בגין שירותים רפואיים חריגים הכלולים בסל זה". בית המשפט פסק בראש הנזק של הוצאות רפואיות ונסיעות סכום גלובאלי של 100,000 ש"ח.

בערעור על פסק דין זה,[35] נקבע כי אומנם פריט הפיצוי בסך 100,000 ש"ח שנפסק בגין הוצאות רפואיות – "אכן לא הוכחו כדבעי", אולם בית המשפט העליון לא מצא להתערב בראש נזק זה מכיוון שבית המשפט קמא השתכנע כי התובע נדרש "לטיפולים שונים, בעיקר טיפולים של רפואה משלימה וטיפול פסיכולוגי לו ולאשתו, שאינם מכוסים בסל הבריאות".

לסיכום, בפרקטיקה המקובלת בתיקים שבהם אין אינדיקציה לצורך בקבלת טיפול מסויים ומיוחד בעתיד, הרי שבתי משפט פוסקים סכום של אלפי שקלים – בדרך כלל עד 10,000 ש"ח, תלוי בכל תיק ונסיבותיו כגון גיל התובע ועוד. פיצויים אלה מגלמים הוצאות שונות שעתיד התובע להוציא לצורך ריפויו שאינם מכוסים בסל הבריאות, כגון: עבור תרופות שהתובע ישלם בעדן ולא יקבל על כך החזר; השתתפויות עצמיות שונות שכמובן משולמות על ידי התובע; עבור רכישת עזרים רפואיים שונים (אורתופדיים וכדומה), אשר יוכח כי אין עבורם החזר מקופת החולים. אם כי במקרים כאלו טוב יהיה אם יהיה להוצאות אלו גיבוי מקצועי על הצורך בהם.

במקרים מורכבים יותר שבהם יוכח כי קיים צורך בטיפולים מיוחדים, כגון: טיפולים פסיכולוגיים, טיפולים פסיכיאטריים, טיפולים נגד חרדה וכדומה, הצורך ברכישת אביזרים שונים, או שיוכח הצורך ברכישת תרופות באופן קבוע לרבות קנביס, לרבות העלות הצפויה לחודש של טיפולים או תרופות אלו,[36] יהיה מקום לכך, כפי

---

35 ע"א 8930/12 **הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' טוויג** (נבו 31.07.2014).

36 על דרכי ההוכחה של הצרכים הרפואיים, הצרכים השיקומיים ועניינים שונים הקשורים בהתאמת דירה ראו, לדוגמה, רע"א 2985/96 **מדלסי נ' גוני**, פ"ד נ(2) 81 (1996).

שנוכחנו מהדוגמאות לעיל, כי בית יפסוק לעתיד, ולו גם באופן גלובאלי סכומים שונים שיגלמו את ההוצאות הצפויות.[37]

11.5 האם יש מקום לפצות בגין שב"ן?

לצידו של סל שירותי הבריאות הבסיסי, חוק ביטוח בריאות מאפשר לקופות החולים להציע לחבריהם להפוך לעמיתים בתכניות לשירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל הבסיסי (שב"ן). אפשרות זו ניתנת, ללא תנאי חיתום, במחיר אחיד לכל קבוצת גיל, ללא תלות במספר שנות החברות בתכנית או במצבו הבריאותי או הכלכלי של העמית.[38]

נשאלת השאלה אם שירותי השב"ן נחשבים סוג של 'חוזה ביטוח' שאז לפי סעיף 86 לפקודת הנזיקין,[39] שווי ההטבות שניתנו לתובע בשל חברותו בשב"ן לא יקוזזו מסך הפיצוי, או שמא לא.[40]

בעניין **פלוני**,[41] בית המשפט קבע כי על אף מאפיינים מסויימים של שב"ן המקרבים אותו לחוזה ביטוח (הצטרפות וולונטרית של המבוטח לשירות, כנגד תשלום, עם קרות 'מקרה הביטוח' הוא יקבל פיצוי מהקופה) בפועל אין הוא כזה. תוכניות שב"ן רבות מציעות שירותים למבוטחים ללא קשר לקרות מקרה ביטוח או להתממשות סיכון, כגון טיפולי שיניים, חוות דעת נוספת, בדיקות תקופתיות

---

37 להשלמה ראו נילי קרקו־אייל וירון ורד "פיצוי גלובלי לניזוק בגין הוצאות רפואיות" **המשפט** 12, 76 (התשס"א) וכן רויטל גרוס, ברוך רוזן ואריה שירום "מערכת הבריאות בישראל בעקבות החלת חוק ביטוח ממלכתי" **ביטחון סוציאלי** 93, 77 (2014).

38 **פלוני**, לעיל ה"ש 2, בס' 33.

39 ראו להלן בפרק 15 בדיוננו על אודות ס' 86 לפקנ"ז.

40 הטעם לחקיקת ס' 86 לפקנ"ז, היה שאם אדם מוציא בעצמו סכומים לביטוחים פרטיים, אזי זכותו ליהנות מסכומי הביטוח בקרות מקרה הביטוח, ואין לקזז את שקיבל מהפיצוי הנזיקי שנפסק לו. כמו כן, אין מקום לאפשר למבטחת שקיבלה כספי פרמיה לחזור בתביעת השבה למזיק.

41 **פלוני**, לעיל ה"ש 2, בס' 40 לפסק הדין, בניגוד לפסק הדין המחוזי.

ושירותים נוספים. יתר על כן, תוכניות שב"ן מציעות למבוטחים להצטרף אף לאחר שאדם חלה במחלה, בניגוד להיגיון הביטוחי שמבקש לבטח אדם על סיכון שטרם התממש. גם מבחינה טכנית, תוכנית שב"ן, שלא כביטוח רגיל, אינה כוללת תנאי חיתום, החרגות, תנאי קבלה ותניות פטור. גובה התשלום לתוכנית שב"ן לא נגזר מהסיכון הצפוי, כפי שמקובל בביטוח, אלא הוא אחיד לכולם. כמו כן הפיקוח על תוכניות השב'ן מבוצע על ידי שר הבריאות או רשות שוק ההון שלא כמקובל בביטוחים 'רגילים".[42]

מטעמים אלו, נקבע כי כספים שמקבל תובע מכוח הסכם שב"ן, לא נחשבים כ'חוזה ביטוח', לכן ניתן לנכות אותם כדין כל הטבה.

בעניין **פלוני**, נחלקו הדיעות אם ניכוי הסכומים שקיבל התובע במסגרת השב"ן ינוכו רק לעבר או גם לעתיד. השופטת וילנר סברה כי אפשר לאשר ניכוי רק של סכומי עבר, מכיוון שכלל לא ברור כי גם בעתיד התובע יהיה זכאי לתשלומי שב"ן, שכן אלו תלויים בתשלום דמי חבר חודשיים וברצונו העתידי של התובע להיות חבר בתוכנית השב"ן. לדעתה, אי אפשר לאכוף על תובע, כחלק מחובת הקטנת ניזקו[43] את החובה להתמיד לאורך שנים בחברותו בתוכנית השב"ן.[44] בחינת התנהלותו של תובע בהקטנת נזקיו היא לפי מבחן הסבירות, היינו עד כמה תובע נוקט אמצעים סבירים להקטנת הנזק, אך לא מעבר לכך. דרישה מהניזוק להצטרף לתוכנית שב"ן או להתמיד בה היא דרישה שמעבר לסביר.

לעומתה שופטי הרוב[45] סברו שאפשר לקזז מתשלום הפיצוי גם כספים עתידיים שהניזוק יכול לקבל משב"ן. נקבע כי:

---

42 **פלוני**, לעיל ה"ש 2, בס' 44–47.

43 השופטת וילנר ציינה (שם, בס' 55 לפסק הדין) כי בניגוד לחובת הקטנת הנזק בדיני חוזים המעוגנת בס' 14(א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א–1971, הרי שחובת הקטנת הנזק בדיני נזיקין, היא יציר הפסיקה, או כחלק מדוקטרינת ה'אשם התורם' שלפיה מזיק לא חייב לשלם על נזק הנגרם ב"אשמו" של התובע.

44 עניין **פלוני**, לעיל ה"ש 2, בס' 56.

45 שם, השופטים עמית ומינץ.

"לעניין זה, איני רואה נפקא מינה אם הטיפול הוא בחינם במסגרת סל הבריאות הבסיסי הקבוע בחוק, או במסגרת תכנית השב"ן אשר מחייבת תשלום חודשי. ודוק: אין לחייב ניזוק להוציא מכיסו על מנת להקטין את נזקו של המזיק, אך מקום בו המזיק נכון לשפות את הניזוק על הוצאה שיש בה כדי להקטין את הנזק, על הניזוק לנהוג כאדם סביר ולעשות כן. בד בבד, אין להרחיק לכת ולומר כי במסגרת חובת הקטנת הנזק, על הניזוק לבחור את קופת החולים המיטיבה ביותר מבחינת תכנית השב"ן, באשר דרישה מעין זו חורגת מנטל סביר של הקטנת הנזק".[46]

נקבע כי אף על פי שהסיכוי העתידי שהשב"ן ייפסק, יגדל, יקטן, או ישנה פניו, הרי שבדיני נזיקין אנו פוסקים על פי המצב הנוכחי. לפיכך נפסק בדעת הרוב לעניין ניכוי תשלומי שב"ן העתידיים, כי:

"על הניזוק להמשיך את חברותו בתכנית השב"ן, או להצטרף לשב"ן, תוך חיוב המזיק לשאת בדמי החבר. גישה זו מביאה גם לאיזון מוחלט של המשולש מזיק-ניזוק-מיטיב. המזיק אינו משלם יותר מכפי נזקו הממשי של הניזוק, הניזוק אינו מקבל יותר מכפי נזקו הממשי, וקופת החולים רשאית לחזור בתביעת שיפוי אל המזיק לפי סעיף 22 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994".

11.6 הוצאות לנסיעות לצורך קבלת טיפול רפואי

מובן כי עבור נסיעות לטיפולים יש מקום לפיצוי בתמורה לקבלות ואסמכתאות וכן בהתאם לקשר הסיבתי לתאונה. יש להעריך כי אסמכתאות על נסיעות לטיפולים ההולמות את סוג הפציעה ואת משכה, בהתאם לנכות שנקבעה תאושר על ידי בית משפט. ככל שהתובע יבקש לאשר הוצאות בגין נסיעות לתקופה ארוכה יהיה עליו לבסס את הצורך לכך. כך, לדוגמה, אפשר יהיה להסתמך על אורך הנכות התפקודית

---

46 שם, עמ' 40 לפסק הדין, ס' 4.

שאישר המומחה, אשר תגובה באישורים רפואיים מרובים שיעידו על קבלת טיפולים באופן אינטנסיבי.

בדומה לשיטת חישוב שהצענו לעיל בפרק עזרת הזולת אפשר גם כאן להציע שיטת חישוב דומה. לפי שיטה זו יהיה מקום להעריך את ההוצאה החודשית לניידות ונסיעות לטיפולים רפואיים על פי הנכות הרפואית או התפקודית שנקבעה לנפגע.

לדוגמה:

ניר בן 35 במועד החישוב. נכותו הרפואית היא בשיעור 30% בגין מגבלות בינוניות בקרסול וברך ימין. גם חישוב בדוגמה זו יתבצע עד לגיל תוחלת חיים שיעמוד על גיל 82.

לניר נותרו 47 שנים עד גיל תוחלת החיים.

מקדם היוון ל־47 שנים עומד על 302.17.

נעריך הוצאות נסיעה ב־250 ש"ח בחודש. סך הבסיס לפיצוי בראש נזק זה יהיה 75,500 ש"ח במעוגל ומסכום זה אפשר לגזור את סך הפיצוי המתאים לגילו ולאופי נכותו של הנפגע.

11.7 תיקון 23 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

לסיום יצוין כי תיקון 23 לחוק פלת"ד,[47] הביא לחקיקת סעיף 2(ב1)(1) לחוק פלת"ד שהעביר את האחריות הביטוחית למתן שירותים רפואיים לנפגעי תאונות דרכים, ככל שאלו נכללים בסל הבריאות מחברות הביטוח המבטחות בביטוח חובה (נזקי גוף) אל קופות החולים.

בכל הקשור לתשלום תכוף, סעיף 5(ב)(1) לחוק פלת"ד מאפשר לתובע לתבוע "הוצאות שהוציא לצרכי ריפויו [...]". אולם תיקון 23 לחוק זה החיל בסעיף 5(ה)(1)

---

47 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 23), התשס"ט–2009, ס"ח 192, אשר פורסם כחלק מחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו־2010), התשס"ט–2009, ס"ח 157.

לחוק פלת"ד הסדר דומה בעניין העברת נטל הפיצוי ממבטחות לקופת חולים גם בעניין פיצוי בגין "צורכי ריפוי" בתשלום תכוף, כך שבגין פריט זה אי אפשר לתבוע תשלום תכוף מהמבטחת.